



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : زينب عبد الرحيم فرغلي السيد

العنوان : شبرا الخيمة

الحي / المدينة : شبرا الخيمة

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

رقم البطاقة : 28704030101203 رقم التليفون : 01128488339

العمر (تاريخ الميلاد) : 03-04-1987 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي : _____

المقرر بما فيه : _____

التوقيع: (_____)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]

قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : _____

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة : _____

الوظيفة : _____

الوظيفة : _____

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة

رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / _____ أ.د. / _____ أ.د. / _____

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : _____

خطة العلاج : _____

المستشفى : _____

قسم : _____

جهة العلاج : _____

نفقات : _____

ملاحظات : _____

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زينب عبد الرحيم فرغلي السيد National ID: 28704030101203	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



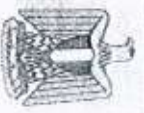
٢٠٢٥/٠١ ٢٨٧٠٤٠٣٠١٠١٢٠٣
يون عيل

متروحة

مسلمة

انق

عمر عبدالحميد عبد الحميد صالح
الطاقة سارية حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٠



دولة الكويت
الجمهورية العربية السورية

زينب

عبدالرحيم فرط السيد

هـ ح الخلفوي

روض الشح - القاهرة

٢٨٧٠٤٠٣٠١٠١٢٠٣



KY9157657

Patient's Name: Zainab Abdulrahim Farghaly El-Sayed
 Date: 2026-05-13
 Referred by: Prof.Dr. no doctor
 Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Multiple bilateral breast lesions and nodules with heterogenous parenchyma, skin thickening and suspected chest wall muscle infiltration on the left side. The largest lesion measures 5 x 4.2 cm on the right side and 34 x 33 mm on the left side. Right axillary lymphadenopathy is also noted with the largest measuring 19 x 15 mm for sono-mammography.
- Marked right pleural effusion with underlying middle and lower lobe subsegmental collapse/ consolidation.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- Few subcentimetric right supraclavicular lymph nodes.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. Two right hepatic lobe segment VIII hypodense focal lesions measuring 10 x 9.7 cm and 10 x 6.6 mm. No dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Multiple subcentimetric para-aortic lymph nodes largest measuring 11 x 9 mm.
- No ascites.
- Multiple axial and appendicular skeleton lytic bone lesions.

Opinion:

Name: زينب عبد الرحيم فرغلي السيد			
MR. : 3420			
Detailed Medical Report			
			السيد
تخية طبية وبعد,,			
إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه MDT discussion on 18/3/2026 reviewed the patient's metastatic breast cancer with liver involvement and discussed initiation of Afinitor, Aromasin, and Zoladex, with a plan for rebiopsy. On 01/04/2026 the patient was shifted to Afinitor and Aromasin for metastatic breast cancer to the liver; Afinitor was started on 29/3/2026 and Aromasin was initiated the same day. On 21/05/2026 the pharmacy noted urgent preparation of weekly Taxol/Carboplatin (Dr. Nermin) with the patient's weight 69 kg, height 159 cm, BSA 1.74, and adjusted body weight 58.5 kg. The regimen was Taxol 130 mg + Carboplatin AUC 2 with labs scheduled 4/5. On 30/05/2026 the oncology note described the patient's history of right breast cancer metastatic to liver and skin, ER 8/8, PR 7/8, HER2-negative, with prior treatments including DP, Fasoldex, Ibrance, Xeloda, and a plan to use Taxol/Carboplatin to bring baseline CTs. Examination revealed an indurated right breast with multiple skin nodules and abdominal wall involvement; the patient was scheduled for week 2 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2. On 08/06/2026 the patient received week 3 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2, with supportive therapy planned for week 4. On 28/06/2026 the pharmacy prepared week 4 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2. On 08/07/2026 the oncology assessment noted decreased right breast induration and skin nodules, with PET-CT on 16/6/2026 showing bilateral breast masses (left 2.7 cm, SUV 4.9), diffuse chest wall and abdominal wall skin thickening, multiple axial and appendicular osseous lesions, left femoral head SUV 4.7, and moderate right pleural effusion. The patient was scheduled for week 5 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2. On 22/07/2026 the patient was clinically improved after week 6 Taxol/Carboplatin, with labs collected in weeks 7 and 8 at pharmacy. On 13/08/2026 the pharmacy noted week 8 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2. On 22/08/2026 the oncology note reported no significant toxicity for week 9 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2, and week 10 and 11 were planned for new CTs. On 31/08/2026 the pharmacy prepared week 10 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2, with labs accepted on 22/8.			
تحريرا في ,			
التاريخ :		21-09-2026	
الوقت :			
الطبيب المعالج :		dina makram	
يعتمد ,			

(MR 3420 (continued, page 2/2 - زينب عبد الرحيم فرغلي السيد

On 12/09/2026 the pharmacy noted week 11 Taxol 140 mg and Carboplatin AUC 2.

The patient has completed 11 weeks of Taxol/Carboplatin therapy.

Patient's Name: Zainab Abdulrahim Farghaly El-Sayed
Date: 2026-05-13
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- ❖ **Marked right pleural effusion with underlying subsegmental middle and lower lobe collapse/ consolidation.**
- ❖ **Two right hepatic lobe focal lesions ? metastatic for dynamic MR study.**
- ❖ **Multiple axial and appendicular skeleton lytic bone lesions likely metastatic for bone scan.**

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy

05/11/2026

MDT FORM

Name:	Zainab / / El-Sayed	MRN:	3420
Age:	39 Y	ID:	28704030101203
Menopausal Status:	PREMENO	Phone:	01129541936
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:		Reason Of MDT:	PD

Clinical Data:

BX:

ER PR HER KI67

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

Rt breast ER 8/8, PR 7/8 HER2 -VE, Rceived ACX4, TAXOTERE X4 8/23 WITH DP AND DEVELOPED LIVER DEPOSITS
received AI/ZOLADEX 1 YEAR
patient on ibrance faslodex for 6 ms
on clinical exam extensive local progression
to shift to affinitor / aromasine with zoladex however
REBIOPSY showed ER 4/8 PR 0/8 HER 2 0

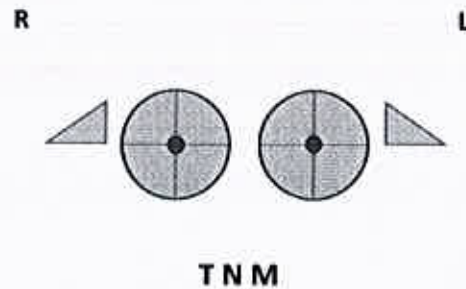
last MDT decison 7/4/2026 > single agent XELODA

Recommendations:

for CT CAP and urgent taxol carboplatin

MDT Outcome & Plan

for CT CAP and urgent taxol carboplatin



SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. شيماء لاشين	د. نرمين مصطفى	د. وائل			

Patient Name : الأستاذة / زينب عبدالرحيم فرغلى السيد	Request No. : 13005220
Patient No. : 28704030101203	Request Date : 24/02/2025
Path No. : 818/25	Verification Date : 13/03/2025
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 37 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report**Clinical Data**

Right breast mass

Nature of specimen

Tru cut biopsy, collected at 24/2/2025, 10:30 am

Gross examination

Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench

Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
- * Perineural invasion: No
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- E-cadherin : Positive
- P63: Negative
- * ER: Moderate nuclear reaction in 70 % tumor cells (Allred score 7/8)
- * PR: Weak nuclear reaction in 5 % tumor cells (Allred score 3/8)
- * HER2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
- * Ki 67: 35 % nuclear reaction of tumor cells

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 17/03/2025 09:53:57

Page 1 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذة / رانيا عبد الرحيم فرغلي السيد	Request No.	13005220
Patient No.	: 28704030101203	Request Date	24/02/2025
Path No.	: 818/25	Verification Date	: 13/03/2025
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis

Right breast mass, Tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II

IPT:

- * ER: Positive (score 7/8).
- * PR: Positive (score 3/8).
- * HER2: Negative (score 0).
- * Ki67: Positive in 35% of tumor cells.

Signature

Dr.Rana Fathy

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 17/03/2025 09:53:57

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / زينب عبد الرحيم فرغلي المريد
 Patient No. : 28704030101203
 Path No. : 3522/22
 Sex : Female
 Age : 35 Y
 Referring Doc. :

Request No. : 13000819
Request Date : 22/11/2022
Verification Date : 19/12/2022
Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA

Left breast: mass&left axilla pathological lymph node

NATURE OF SPECIMEN

Two cut biopsies, collected at 22/11/2022, 1:05 p.m and 1:15 p.m.

GROSS EXAMINATION

Two specimens were received:

- Two specimens were received :
 1) Left breast mass :Multiple(4) grayish white tissue cores up to 2 cm , totally submitted
 2) Left axilla pathological lymph node: Fragmented greyish white tissue cores up to 1.5 cm , totally submitted

MICROSCOPIC EXAMINATION

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+3+2) Grade III
- * DCIS: No
- * Angiolysis: Couldn't be detected in the received biopsy
- * Perineural invasion: No
- IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).
- IPT (Positive control showed appropriate reactivity)
- * ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 7/8)
- * HER2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
- * Ki 67: 50 % nuclear reaction of tumor cells

Verified by :
suamah sayed

Printing Date : 21/12/2022 12:10:54

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

شركة رقم (4) = المصنع الأول = دولي رقم (287) = كبرياوي الثاني = مصنع 55 دولة = قلاوي ... مصنع
Russe No. (4) - First Floor-Building No. 287-2ND. Corridors - 3rd Fl. 51 Qa Sana - Gahm
Baqat

Patient Name: Zainab Abd Al Rahim Farghaly Al Sayed	Date : 25/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 5046/2022	Pat. ID: 25944

POST- CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

1. Chest:

- Known case of left breast cancer showed left breast diffuse skin thickening and parenchymal asymmetrical density.
- bilateral axillary level I & II lymph nodes largest measuring currently 13x10mm.
- Newly developed moderate right breast skin thickening.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no pericardial effusion detected.

2. Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with segment VIII hypodense lesions the largest is seen measuring about 10 mm showed no enhancement in the arterial phase.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes..
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- **Still seen** scattered vertebral, sternal and pelvic lytic lesions.